

Paciente ventilado y monitorizado

El SAVe ventila · el LIFEPAK vigila · tú decides

Ante la duda: bolsa-
mascarilla

1 Conectar en orden

1

Vía aérea

colocada y comprobada
según protocolo

2

SAVe II+

altura · CONFIRM · alarmas
probadas

3

EtCO2

curva regular = aire en los
pulmones

4

ECG · SpO2 · PNI

PNI cada 5 min: la presión
positiva puede bajar la PA

2 Ronda cada 5 min (y tras mover)

- ☐ ¿Sube el tórax por igual?
- ☐ SpO2 estable
- ☐ EtCO2: curva presente y valor estable
- ☐ FC y PA
- ☐ SAVe: CONFIRM → PIP y PEEP medidas

3 Alarmas: sigue este orden

1 · Paciente: ¿pulso? ¿tórax?

- 2 · Vía aérea: ¿tubo en su sitio? (EtCO2)
- 3 · Ventilación: ¿qué dice el SAVe?
- 4 · Circulación: ritmo y PA
- 5 · Equipo
- ¿30 s sin tenerlo claro? → bolsa y seguir pensando

4 Capnografía: qué te dice

Curva regular

Ventilación llegando a los pulmones

Desaparece de golpe

Tubo desplazado · desconexión ·
parada

Sube de golpe en RCP

Posible recuperación: pulso en la
siguiente pausa

5 Parada en paciente ventilado

Compresiones YA

+ orden de parar

SAVe FR 0

1 resp./6 s

¿Tórax?

PIP
repetido
→ bolsa al
tubo

Analizar

vehículo
detenido

Descarga: nadie toca · O2 libre a > 1 m · SAVe fijado (puede seguir conectado). **Si recupera pulso: salir de FRO** (altura + CONFIRM).

6 Límites

< 8 años

Modo DEA no diseñado para ellos → protocolo pediátrico de la dirección médica

< 45 kg o sin EtCO2

SAVe: no → bolsa del tamaño adecuado

Humo / CO

SpO2 engaña · SAVe nunca en la zona

Traslado: fijar ambos equipos · pantallas a la vista · LP12 con 2 baterías, SAVe cargado · radios lejos · entrega: 12D + CODE SUMMARY + ajustes del SAVe